12.1.1. 의무기록/의료정보 관리

제 정 일	2008.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의무기록위원회, 표준화위원회, 의무기록팀				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 12.1 의료정보/의무기록 관리 JCI Standard 7th Edition: MOI.1~13

제1조 (목적)

1. 의무기록의 작성, 보관, 대출, 열람 및 공개 등의 관리와 기타 의무기록에 관한 사항에 대해 규정하여 의료진 간 정확하고 효율적인 의사소통을 위해 의무기록을 관리하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 의무기록(Medical Records): 의사, 간호사, 의료기사 등이 의료진이 환자의 진료에 관한 각종 정보를 소정의 양식에 기록한 문서이며, 이를 보관하기 위한 마이크로필름, 광파일형태, 전자적으로 작성된 의무기록의 자료(Data) 및 전자의무기록(Electronic Medical Records)을 포함한다.
2. 미비기록(Incomplete Chart): 입원환자의 기록이 퇴원 시까지 완성되지 않은 기록을 의미한다.
3. 미완성 종결차트(Delinquent Chart): 입원환자의 기록이 퇴원 후 4주 이내까지도 완성되지 않은 기록을 의미한다.
4. 의무기록 서명: 병원에 등록된 수기서명(스캔된 이미지 서명 포함)과 전산시스템에 등록된 전자서명을 총칭하되, 전자서명은 공인인증에 따른 전자서명을 의미한다.

제3조 (절차)

1. 의무기록/의료정보 관리 위원회
   1) 의무기록위원회
      (1) 의무기록의 작성, 보관, 보존 등의 관리와 기타 의무기록에 관한 중요사항에 대하여 심의한다.
      (2) 의무기록위원회의 구성, 역할, 운영 등은 [부록1. 세브란스병원 제위원회 운영내규-의무기록위원회]에 따른다.
      (3) 의무기록위원회는 연 2회 개최함을 원칙으로 하되 필요 시 수시로 소집할 수 있고 위원회 운영 결과는 경영진에게 보고하고 관련 직원들과 공유한다.
   2) 표준화위원회
      (1) 데이터 표준화 및 데이터 품질관리에 관한 사항과 연구 활성화를 위한 중요사항에 대해 심의한다.
      (2) 표준화위원회의 구성, 역할, 운영 등은 [부록2. 세브란스병원 제위원회 운영내규-표준화위원회]에 따른다.
      (3) 표준화위원회는 연 2회 개최함을 원칙으로 하되 필요 시 수시로 소집할 수 있고

위원회 운영 결과는 경영진에게 보고하고 관련 직원들과 공유한다.

2. 의무기록/의료정보 관리 직원의 자격 및 교육
   1) 자격 및 교육: 보건의료정보관리사 면허 소지자로 의료기사 등에 관한 법률에 따라 보수교육을 이수한 자
   2) 의무기록팀 소속 일반 행정 직원의 경우, 의무기록 관리업무를 보조하며, 의무기록팀 전 직원은 원내 필수교육, 직무교육 등 업무 수행에 필요한 교육을 이수한다.

3. 의무기록 수정, 추가, 삭제 등 정정관리에 대한 범위 및 방법, 절차, 이력 관리 사항은 세브란스병원 내규 [12.1.2. 환자정보 및 의무기록 정정]을 따른다.

4. 의무기록/의료정보 접근 권한 관리
   1) 의무기록의 조회(열람) 및 입력, 출력 등 접근권한은 병원에서 정한 업무상 필요한 범위 내로 제한하며 구체적 범위, 접근권한 관리 및 책임에 관한 사항은 세브란스병원 내규 [12.1.3. 의무기록/의료정보 접근권한]을 따른다.
   2) 진료용 이외의 연구용, 집담회용 등으로 열람 신청할 경우 권한관리자는 신청자, 신청용도, 신청목적, 열람기간 등을 확인하여 승인한다.
   3) 본원 직원이 연구 용도로 의무기록을 검색, 조회하고자 할 때는 세브란스병원 내규 [12.3.1. 의료정보수집 및 정보공유활용]에 따른다.
   4) 연세대학교 소속 학생이 의무기록을 연구용 등으로 열람하고자 할 때는 연구 담당교수의 확인을 받아야 하며, 확인한 교수는 그 학생이 의무기록을 열람함으로써 발생하는 문제에 대하여 공동 책임을 진다.
   5) 환자, 외부인 또는 기관에서 의무기록 열람을 요청하는 경우에는 관련법에 따라 제공한다.

5. 의무기록 사본발급과 관련한 범위, 대상자별 절차, 이력 및 발급 관리 등에 관한 사항은 세브란스병원 내규 [12.1.4. 의무기록 사본발급 및 열람]을 따른다.

6. 금기약어, 금기기호 사용 및 목록 관리는 세브란스병원 내규 [12.1.5. 약어 사용]을 따른다.

7. 의무기록 보관, 보존 및 파기 관리
   1) 의무기록은 최소 관련 법령이 정하는 기간 동안 관리 및 보존하며, 진료의 연속성이나 연구 등의 목적으로 법적 보관연한 이상 보존할 수 있다.
   2) 기록은 손상, 분실, 변조, 파기, 무권한 접근으로부터 정보보호 규정 및 지침서에 따라 보관된다.
   3) 수기 의무기록이 보관된 장소는 통제구역으로 지정하여 출입관리하며 화재예방을 위한 소화 시설이 마련되어야 하고, 전자의무기록 내용이 저장된 관련 시스템은 안전한 곳에 보관하며 보관실은 출입을 통제한다.
   4) 진료의뢰서, 타병원 진료기록 등의 의무기록 및 영상기록물은 스캔, 영상등록 등의 방법을 통해 전자의무기록과 통합하여 조회할 수 있도록 한다.
   5) 전자의무기록의 백업 및 복구 관리

(1) 의료정보의 보안수준에 따라 백업의 수준을 결정하여 백업을 시행하여야 한다.
(2) 백업된 자료는 본관 데이터센터 재난 발생 시 영향을 최소화하기 위해 별도의 건물에 마련된 원격지에 보관하여야 한다.
(3) 재난에 대한 대비 조치를 주기적으로 점검하고 백업이 제대로 되었는지를 확인하는 과정을 거쳐야 한다.
(4) 시스템 장애에 대비하여 각 시스템별, 서버별 중요도에 따라 시스템 이중화, 백업관리, DR 시스템 운영관리 등에 대한 복구대책을 수립하고 시행한다.
(5) OCS/EMR DR 시스템의 모의 훈련을 정기적으로 수행하여 OCS/EMR DR 시스템의 정상가동을 확인한다.
(6) 기타 시스템 전반에 대한 장애 복구 대책은 시스템 관리부서의 백업 및 복구가이드에 준하여 시행한다.
(7) 전자인증의 경우 정보보호 규정 및 지침서의 인적 보안 지침에 따라 관리한다.

6) 법적 보관연한이 경과하여 의무기록을 파기할 때는 진료정보가 누출되지 않도록 안전하게 파기하며 전자적 파일 형태인 경우는 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제하고, 기타 서면 등 기록 매체인 경우는 병원에서 정한 '문서 규정'상의 폐기 절차에 따라 폐기한다.

7) 환자가 보관연한이 경과한 의무기록에 대하여 삭제 요청 시에는 병원장 결재를 득한 후 보존기간이 지난 의무기록에 대하여 파기한다.

8. 의무기록 작성 기준

1) 의무기록 작성 원칙

(1) 의무기록은 전자의무기록으로 작성되어야 하며, 그 외 종이에 작성된 의무기록은 스캔 등의 방법을 통해 전자의무기록으로 통합한다.
(2) 의무기록은 표준화된 기록의 형식과 내용으로 읽기 쉽게 작성하며, 기록의 적시성을 준수하여 작성한다.
(3) 의무기록 작성은 의료행위를 시행한 자가 작성하되, 필요에 따라 주치의(담당교수)가 공동 서명할 수 있다. 단, 진료지원간호사는 세브란스병원 지침에 따라 업무 범위에 해당하는 기록에 한해 초안 작성 및 오입력에 대해 수정을 할 수 있으며 이에 대해서는 주치의(담당교수)가 최종 확인 및 전자서명 한다.
(4) 의무기록의 수정은 종이에 작성된 의무기록이 잘못 기록된 경우에는 기록 내용이 보이도록 한 줄 긋고 수정사항 및 수정날짜를 기재한 후 작성자 서명을 한다. 전자의무기록으로 작성된 기록은 수정 전의 내용, 작성자 및 작성 일시를 조회할 수 있어야 한다.
(5) 의무기록 작성자는 사실에 입각하여 기록하며, 완결된 의무기록과 사본발급이 완료된 의무기록은 정정할 수 없다. 단, 명백한 오류나 착오 기재 또는 기타 사유로 인해 기록 내용에 대해 수정이나 삭제가 필요한 경우에는 세브란스병원 내규 [12.1.2. 환자정보 및 의무기록 정정]에 따라 관리한다.
(6) 의무기록에는 환자의 인적사항, 병력, 질병상태, 검사, 진단, 경과, 치료 및 결과에 관한 모든 정확한 정보가 있어야 하며, 모든 의무기록에는 환자의 인적사항과 작성일시, 작성자의 서명이 있어야 한다.

(7) 사용하는 용어는 한글로 기록하되 진단명, 약제명, 검사명 등의 의학용어는 영어로 기록할 수 있다. 퇴원요약지의 최종진단명은 영어로 기록하고 약어를 사용하여서는 안된다.

(8) 약어는 원내의 승인된 공식약어를 사용하며 공식약어 및 금기약어/기호 목록과 구체적인 사용 원칙 및 절차는 세브란스병원 내규 [12.1.5. 약어 사용]에 따른다.

(9) 진단명 분류는 [국제표준질병사인분류(ICD, International Classification of Diseases)], [한국표준질병사인분류(KCD, Korean Standard Classification Of Diseases)], 수술/시술명 분류는 [국제의료행위분류(ICD-9-CM, International Classification of Diseases 9th Revision Clinical Modification)] 또는 EDI(Electronic Data Interchange) 코드를 사용하며 세브란스병원 내규 [12.1.6. 의무기록 관련 표준 코드]에 따라 관리한다.

(10) 주진단명 표기 방침은 세브란스병원 내규 [12.1.7. 진단명 및 진단코드 관리]에 따른다.

2) 입원환자 의무기록

(1) 입원기록 (세브란스병원 내규 [2.2.2.1. 입원환자 평가] 참고)

① 병동 입원환자의 입원기록은 입원 후 24시간 이내에 담당의사가 작성하고 주치의(담당교수)가 공동 서명한다.

② 입원기록에는 입원 시 진료과, 주호소, 병력, 신체검진, 추정진단, 치료계획, 퇴원계획 등을 포함하며 세브란스병원 내규 [2.2.2.1. 입원환자 평가]의 입원환자 초기평가 내용에 따라 작성한다.

③ 응급진료센터에서 입원이 결정되는 경우, 병동 입원 전에 입원기록을 작성할 수 있다.

④ 안정실과 당일입원실 등 단기 입원환자는 별도의 단기 입원환자 기록을 이용할 수 있다.

(2) 경과기록 (세브란스병원 내규 [2.2.2.1. 입원환자 평가] 참고)

① 경과기록에는 환자의 상태 변화, 임상경과, 치료나 처치내용 및 이에 대한 반응, 결과, 합병증 혹은 부작용 유무 및 이에 대한 진단, 치료 계획 등을 발생 순서대로 상세히 기록한다.

② 담당의사가 작성한 경과기록에 대해서는 주치의(담당교수)가 공동 서명한다.

③ 1일 1회 이상 작성하되, 급성이 아닌 재활치료를 목적으로 입원하고 있는 환자의 경우 3일에 1회 이상 평가하며 상태변화가 있는 경우 추가로 작성한다. 단, 주말(토/일요일), 공휴일, 퇴원일에는 상태변화가 있는 경우에만 작성한다.

④ 장기 재원환자의 경우, 재원일수 30일 경과 시마다 현재 질병상태 및 경과, 신체검진 등 환자의 전반적인 상태에 대하여 '장기재원환자 재평가 기록'을 작성한다.

⑤ 주치의(담당교수)가 환자 상태에 대해 상세한 내용을 기록하고자 할 때에는 '주치의(담당교수) 경과기록'을 작성할 수 있다.

(3) 수술 전 환자상태 평가기록

① 수술실 입실 전에 수술과 담당 의사가 작성하고 수술 집도의가 공동 서명한다.

② 수술 전 검사결과 및 수술 전 의학적 평가, 수술 전 진단명, 예정수술명 등의 내용을 기록한다.

③ 응급수술인 경우에는 수술 전 환자상태 평가기록을 생략하고, 진단명 등 주요 환자상태에 대해서만 간략히 기록할 수 있다.

(4) 수술실 노트

① 수술실 노트는 환자가 회복실 퇴실 전까지 작성한다. 수술 후 중환자실로 이동하는 경우 중환자실 도착 전까지 작성하되, 수술에 참여한 의사가 동반하여 이동하는 경우에는 이송 후에 작성할 수 있다.

② 수술실에서 행해진 모든 수술/시술에 대해 작성하며, 수술 전/후 진단명, 집도의 및 보조의 이름, 수술명, 검사를 위해 채취한 조직표본 검체, 수술 중 특이사항(합병증 등), 출혈량, 수술일자, 작성자 및 집도의 서명 등을 기록한다.

③ 수술기록이 '①'의 시간까지 완성이 된 경우는 수술실 노트 작성을 생략할 수 있다.

(5) 수술기록

① 수술 후 48시간 이내에 수술에 참여한 의사가 작성하며 집도의가 공동 서명한다.

② 수술 전/후 진단명, 집도의 및 보조의 이름, 수술명, 발견사항 및 수술과정, 검사를 위해 채취한 조직표본 검체, 수술 중 특이사항(합병증 등), 출혈량, 수술일자, 작성자 및 집도의 서명 등을 기록한다.

(6) 수술 후 환자상태 평가기록

① 수술 후 24시간 이내 수술과 담당 의사가 작성하며, 수술 집도의가 공동 서명한다.

② 수술 후 환자상태 평가내용과 치료계획을 기록한다.

(7) 진정 전, 중, 후 기록 (세브란스병원 내규 [5.4.1. 성인 진정관리] 참고)

① 진정 시행 전에 진정자격을 가진 의사가 진정 전 환자 평가 기록을 작성한다.

② 진정 또는 모니터링 자격을 가진 의사 또는 간호사가 진정 중과 후 모니터링 기록을 작성한다.

(8) 마취 전/마취 직전 환자 평가서 (세브란스병원 내규 [5.5.1. 마취진료] 참고)

① 마취 전 환자 평가는 수술실 입실 전에 마취통증의학과 의사에 의해 시행되며, 환자의 신체검진 및 검사결과, 마취 관련 과거력, 신체상태 분류, 마취 계획, 평가 시행자 등을 기록한다.

② 마취 유도 직전 환자 평가는 마취통증의학과 의사에 의해 시행되며 환자의 생리학적 안정성 등을 평가하고 기록한다.

(9) 마취기록 (세브란스병원 내규 [5.5.1. 마취진료] 참고)

① 전신마취 또는 부위마취가 시행된 수술에 대해 마취제 종류 및 용량, 마취 방법 등을 마취통증의학과 의사가 작성한다.

② 마취 중 상태를 모니터링하고 환자의 생리학적인 상태를 기록한다.

(10) 회복기록 (세브란스병원 내규 [5.5.1. 마취진료] 참고)

① 환자가 회복실을 이용한 경우 회복실 간호사가 작성한다.

② 회복실을 이용하지 않는 환자의 수술 후 상태는 임상관찰기록지 및 해당부서 관련 기록지에 작성한다.

③ 회복 중인 환자의 상태를 모니터링하고 기록한다.

④ 회복실 퇴실 전에는 퇴실기준에 부합되는지를 평가하고 마취 후 회복점수를 기록한다.

(11) 전출 및 전입기록 (세브란스병원 내규 [2.1.4.1. 환자정보 공유 및 인수인계] 참고)

① 치료받는 진료과가 달라지는 경우, 다른 진료과로 환자를 보내는 진료과 의사가 전출 처방 입력 전까지 전출기록을 작성하고, 환자를 받는 진료과 의사가 전입 후 24시간 이내까지 전입기록을 작성한다.

② 전출 및 전입기록에는 환자의 진단명, 경과 및 특이소견, 수술 및 시술 내용, 전과 사유, 환자 상태 등을 기록한다.

(12) 인계기록 및 인수기록 (세브란스병원 내규 [2.1.4.1. 환자정보 공유 및 인수인계] 참고)

① 같은 진료과 내에서 담당 의사가 바뀌는 경우 인수인계 담당 의사가 환자의 진단명, 경과 및 특이소견, 인계/인수 시 환자 상태 등을 간략하게 기재한다.

② 인계기록은 환자 인계 전, 인수기록은 환자 인계 후에 기재한다.

③ 진료과 변동 없이 중환자실 입실, 퇴실 시 담당 의사가 변동되는 경우 기재할 수 있다.

(13) 중환자실 입실, 퇴실기록 (세브란스병원 내규 [2.1.3.1. 입퇴실 절차 – 중환자실] 참고)

① 중환자실에 입실, 퇴실할 경우 담당 의사는 환자의 상태가 입실, 퇴실 기준에 부합하는 지의 여부를 확인하여 작성한다.

(14) 침습적 시술기록 (세브란스병원 내규 [5.3.1. 시술관리] 참고)

① 시술을 시행한 경우에는 해당 침습적 시술 기록지를 작성한다.

② 시술에 참여한 의료진이 시술실 퇴실 전에 시술에 대한 내용을 작성하며, 시술 전 진단명, 시술명, 집도의/보조의 이름, 시술 후 진단명, 검사를 위해 채취한 검체, 출혈정도, 기타 특이사항, 시술기록 작성일시 및 작성자 서명 등을 포함하여 기록한다.

③ 침습적 시술의 범위는 세브란스병원 내규 [1.3.2. 시술의 정확한 수행]을 따른다.

(15) 동의서

① 동의서의 작성, 절차 및 서식은 세브란스병원 내규 [6.5.1. 동의서]에 따른다.

(16) 의사지시

① 의사는 환자의 진단과 치료에 필요한 검사, 처치, 투약 등의 지시한 내용, 날짜, 서명 등을 기록한다.

② 구두 처방인 경우, 세브란스병원 내규 [1.2.1. 구두/전화처방]을 따른다.

③ 진단영상과 임상검사의 판독과 결과 보고에 필요한 경우 임상적 이유가 처방에 포함된다.

④ 퇴원 시 담당 의사의 퇴원지시가 있어야 하며 퇴원형태(퇴원지시 후, 타병원 전원, 자의 퇴원, 탈원 등)를 구분하여 기재한다.

⑤ 의사지시는 의무기록에 포함되며, 취소되면 반드시 처방을 철회(discontinue) 하여야 한다.

(17) 사망기록

① 환자 사망 후 사망을 선언한 의사가 작성하고 서명한다.

② 사망기록에는 사망일시, 사망원인(선행사인, 중간선행사인, 직접사인), 임종까지의 경과, 임종시의 상황, 사망의 객관적 증거 등을 기재한다.

(18) 말기환자평가

① 연명의료결정법에 따른 법정서식을 작성하고, 연명의료계획이 수립된 환자로

처방이 된 경우에는 말기환자평가(End of life Assessment) 서식을 의사가 작성하고 서명한다.

② 연명의료결정법에 따른 법정서식의 작성 방침은 세브란스병원 내규 [3.1.7.2. 연명의료결정 환자 진료]에 따른다.

(19) 퇴원요약 (세브란스병원 내규 [2.1.5.1. 퇴원] 참고)

① 환자 퇴원 전에 담당 의사가 작성하며 주치의(담당교수)가 공동 서명한다.

② 퇴원요약에는 진단명, 수술 및 처치명, 입원사유 및 경과요약, 퇴원 시 환자상태, 추후관리계획 등을 기록한다.

③ 안정실과 당일입원실 환자의 경우 별도의 단기 입원환자 기록을 이용할 수 있으며, 단기 입원환자 기록을 작성한 경우는 퇴원요약을 생략할 수 있다.

④ 환자 퇴원 시 환자용 퇴원요약지 1부를 제공한다.

(20) 검사결과지

① 검사를 시행한 경우, 공식적 검사결과지가 빠른 시일 내에 의무기록에 첨부된다.

(21) 협의진료 의뢰서 (세브란스병원 내규 [3.1.2.1. 협의진료체계] 참고)

① 협의진료 의뢰서는 주치의(담당교수) 전문영역 밖의 문제가 발생한 경우, 보다 정확한 진단과 치료를 위하여 다른 임상과 전문의에게 협의진단을 의뢰하는 경우 작성한다.

② 협의진료를 의뢰하는 의사는 협의진료 의뢰사유 및 내용, 응급여부 등을 구체적으로 기재하고 서명한다.

③ 협의진료를 의뢰받은 의사는 환자기록 검토 후, 환자를 평가하고 주치의(담당교수)와 상의하여 소견과 추측 진단명, 필요한 검사나 권장하는 처방, 처치 등 회신내용 및 회신일자를 기재하고 서명한다.

④ 협의진료 결과가 확인되어 진료나 처치가 제공된 중요한 진단명은 퇴원요약에 기재할 수 있다.

⑤ 환자의 급격한 상태변화가 있거나 응급 수술/시술이 필요한 경우에는 응급 협의진료를 의뢰하며, 협의진료를 의뢰받은 의사는 24시간 이내 회신한다.

(22) 의료인 외 전문분야 직종 기록

① 의사, 간호사 외 환자의 치료에 관여하는 직종의 전문가가 환자의 진료에 참여 시 환자 평가 등 환자에게 수행한 내용의 기록을 작성한다.

(23) 단기 입원환자 기록

① 안정실, 당일입원실 등 단기 입원환자는 환자의 상태와 치료 등에 대해 간략히 기록하는 별도의 서식을 사용할 수 있다.

(24) 입원간호에 관한 기록

① 입원 시 환자상태 평가: 간호초기평가 기록은 간호사가 입원 후 24시간 이내에 작성한다. (세브란스병원 내규 [2.2.2.1. 입원환자 평가] 참고)

a. 일반정보 및 입원정보

b. 현병력 및 과거력, 가족력

c. 투약내역, 입원 및 수술력

d. 전반적인 건강 상태에 대한 평가 및 신체사정

e. 퇴원계획 및 교육 요구도

f. 사회 및 경제적 상태, 문화적 및 종교적 특수성
g. 잠재적 위험 요인 평가: 낙상, 욕창
h. 작성일시 및 작성자 서명
② 입원경과기록
a. 임상관찰
a) 활력증상: 체온, 맥박, 호흡, 혈압, 신장, 체중, 산소포화도 등
b) 섭취량과 배설량
b. 투약 및 처치 시행
c. 서술형 간호 기록
a) 환자 상태 변화
b) 특수 검사나 치료 시행 기록
c) 병실 이동과 관련된 기록
d) 교육관련 기록
(a) 교육계획: 교육요구도 및 교육장애요소 평가
(b) 교육 내용
(c) 교육 방법 및 매체
(d) 교육 대상
(e) 교육이해도 평가
e) 작성일시 및 작성자 서명
③ 수술(시술) 관련 기록
a. 수술(시술) 전 환자 확인, 수술부위표시 확인, Time out 시행 및 기록
b. 수술(시술) 전 처치
c. 수술(시술) 전·후 피부상태 확인 및 기록
d. 수술계수(Counts) 확인 및 기록
e. 수술(시술) 시 검사를 위해 채취한 검체 기록
f. 작성 일시 및 작성자 서명
④ 퇴원관련 기록
a. 퇴원 간호기록
b. 퇴원 시 환자 상태 평가
c. 작성 일시 및 작성자 서명
(25) 건강증진센터기록
① 건강검진만을 목적으로 건강증진센터에 입원한 경우, 위의 원칙을 따르지 않고, 별도의 기록을 작성할 수 있다.
3) 응급진료센터 의무기록
(1) 응급진료기록
① 응급진료센터에 내원한 모든 환자에 대하여 응급진료기록을 작성하며 세브란스병원 내규 [2.2.3.1. 응급진료센터환자 평가]에 따른 응급환자분류체계를 통해 환자를 평가한다. (진료 외 방문 제외)
② 환자상태에 따라 응급의학과 또는 타 진료과 의사가 작성하며 환자진료와 관련있는 타 부서 또는 타 직종의 직원들도 필요 시 해당 환자의 초기평가 기록을

의무기록 접근 권한 안에서 공유한다.

(2) 경과기록

① 응급진료센터에 1일 이상 체류하는 경우, 경과기록에 환자 상태를 평가하여 1일 1회 이상 작성한다.

(3) 응급진료센터 퇴실기록

① 환자가 입원하지 않고 응급진료센터에서 퇴실하는 경우, 퇴원과의 담당 의사가 응급진료센터 퇴실기록을 작성한다.

(4) 침습적 시술 기록

① 입원에서의 침습적 시술과 동일하게 작성한다.

(5) 협의진료의뢰서

① 입원에서의 협의진료와 동일하게 작성한다.

(6) 의사지시

① 응급진료센터에서 내려진 의사지시 내용을 기록한다.

(7) 검사결과지

① 응급진료센터에서 행해진 검사에 대한 결과는 가능한 빠른 시간 내에 첨부한다.

(8) 응급진료센터 간호기록

① 응급진료센터에서 행해진 간호에 대해 담당 간호사가 기록한다.

(9) 이송기록

① 응급진료센터에서 타 기관으로 이송 시, 응급환자진료의뢰서를 작성하여 전원받는 기관에 제공한다.

② 이송 중 환자의 상태를 전원환자 이송기록에 기록한다.

4) 외래환자 의무기록

(1) 외래진료 시 영양, 기능, 통증, 낙상 스크리닝을 포함한 외래초기평가 기록을 작성한다.

(2) 외래 초진기록

① 해당 진료의사는 처음 진료받은 환자에 대해 작성한다.

② 병원 공통평가 항목 및 임상과마다 정해진 필요한 최소의 평가항목을 기재한다.

③ 외래 초진기록의 공통 평가 항목과 임상과 최소 평가항목은 세브란스병원 내규 [2.2.1.1. 외래환자 평가]에 따른다.

(3) 외래 재진기록

① 해당 진료의사는 환자가 외래진료 재방문 시마다 작성한다.

② 세브란스병원 내규 [2.2.1.1. 외래환자 평가]에 따라 기록한다.

(4) 의사지시

① 외래진료 시 의사지시 내용을 기록한다.

(5) 검사결과지

① 응급진료센터에서 행해진 검사에 대한 결과는 가능한 빠른 시간 내에 첨부된다.

(6) 침습적 시술 기록

① 입원에서의 침습적 시술과 동일하게 작성한다.

(7) 수술실 노트

① 외래환자가 수술실에서 수술/시술이 시행된 경우, 수술시술 참여 의사가 작성한다.

(8) 협의진료기록

① 입원에서의 협의진료와 동일하게 작성한다.

(9) 외래환자 요약지

① Smart viewer를 이용하여 주요 진단, 약물, 알레르기, 현재 복용하는 약물, 외과적 시술 병력, 입원병력 등 실시간 업데이트된 환자 요약 정보를 조회한다.

9. 의무기록 완결도 관리

1) 양질의 의무기록 관리를 위하여 의무기록팀에서는 세브란스병원 내규 [12.2.2. 의무기록 완결도 관리]에 따라 의료정보/의무기록 관리의 성과를 지속적으로 관리하며 질향상 및 지표관리 활동, 결과를 경영진에 보고하고 관련 직원과 공유한다.

2) 의무기록의 완결성 결과에 따라 상벌제를 운영할 수 있다.

3) 의무기록 작성자는 각 직종에서 작성한 의무기록을 표본 추출하여 자체 평가하며, 그 결과를 의무기록위원회에 정기적으로 보고한다.

4) 의무기록은 각각 정해진 시한 내에 작성되어야 하며, 미비기록은 빠른 시일 내에 완성되도록 의무기록팀에서 관리한다.

5) 미비기록은 퇴원 후 4주 이내에는 완성되어야 한다. 4주 이후에도 완성되지 않은 기록(Delinquent chart)을 해당 작성 책임자 및 주치의(담당교수)에게 통보하며, 병원장에게 보고 후 행정적 규제를 할 수 있다.

6) 외래기록은 환자 진료일로부터 일주일 이내에 작성 완료한다.

10. 의무기록의 색인 및 퇴원요약정보 Database 관리

1) 의무기록 보존 시에는 개별 의무기록에 대한 색인을 구축하여 관리한다.

2) 의무기록팀에서는 퇴원요약 DB를 구축하여 원내·외 통계산출이나 정보제공 등에 활용한다.

3) 구축된 색인을 이용하여 병원의 기본적인 통계를 산출하여 정기적으로 보고한다.

11. 자료와 정보수집 및 이용

1) 사용자(원내·외 직원) 요구를 확인하여 자료와 정보를 수집하고 생성하여, 적시에 환자진료, 교육, 연구, 경영 및 질 관리를 지원한다.

2) 보건정책기관 요청에 따라 조사자료를 제공한다.

3) 정보수집 및 이용 절차는 세브란스병원 내규 [12.3.1. 의료정보수집 및 정보공유활용]에 따른다.

12. 의무기록 서식 및 용어, 약어 관리

1) 의무기록 서식의 제정 또는 개정이 필요한 경우는 요청자가 부서장의 서명을 받은 '서식 제·개정 신청서'를 제출하여야 한다.

2) 서식 제·개정 신청 건 중 공통 및 필수서식은 의무기록위원회 심의를 거쳐야 하며, 임상과별 개별 서식은 관리부서인 의무기록팀에서 표준 관리에 검토가 필요한 건에 대해서만 의무기록위원회 심의를 거친다.

3) 진단용어를 비롯한 병원 용어 및 약어 마스터는 의무기록팀에서 관리한다.

4) 진단 및 의료행위 등 마스터의 분류코드는 세브란스병원 내규 [12.1.6. 의무기록 관련

표준 코드]에 따라 표준화된 분류를 이용하며, 최신성이 유지되도록 관리한다.

13. 교육
   1) 의무기록팀은 의무기록 작성자를 대상으로 작성에 대한 교육을 정기적 또는 필요 시 수시로 수행한다.
   2) 의무기록팀 또는 디지털헬스실은 환자 개인정보보호에 대한 교육을 정기적 또는 필요 시 수시로 수행한다.

14. 보호 및 보안
   1) 환자정보는 비밀사항으로 환자의 의무기록 및 정보를 접하는 모든 직원은 개인정보보호에 대한 정기적인 교육을 받는다.
   2) 세브란스병원 내규 [12.4.1. 개인정보 보호 및 보안]에 따라 의무기록팀을 비롯하여 환자의 의무기록 및 정보를 접하는 모든 직원과 외부 용역직원은 임용 시 업무와 관련하여 얻게 되는 환자의 개인정보에 대해 보안을 유지할 것을 서약하는 '정보보호 서약서'를 작성한다.

제4조 (부록)
1. 세브란스병원 제위원회 운영내규 – 의무기록위원회
2. 세브란스병원 제위원회 운영내규 – 표준화위원회

제5조 (참고)
1. 의료법 제19조, 제21조, 제22조, 제23조

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2008년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)